

藥局辨識民眾是否可購買緊急事後避孕藥

(Emergency Contraceptive Pill, ECP) 之評估與轉介流程表

本版為 2026-08-03 更新版（原版：01_藥局供應 ECP 評估與轉介流程表.md，2026-07-18 修訂，保留未動）。更新依據：2026-08-03 台灣婦產科醫學會張維君理事長、黃建霈秘書長對議題 1-5 之回應（詳《0803 婦產科醫學會對於 5 議題之回應_會議紀錄》）+ 第 3 場專家會議決議（2026-07-08）+ 日本「懷孕可能性判斷流程」與「緊急事後避孕藥銷售核對表」+ 國際指引（FSRH/ACOG/WHO）。試辦藥品以 LNG（Levonorgestrel）為限。

本次變更摘要：● 議題 1-5 全數獲醫學會回應，原 ● 標記依回應改為定案或維持；另新增制度定位說明與轉介未就醫者之追蹤要求。

議題	原標示	本版處理
1 血栓／子宮外孕病史／PID	● 待確認	✓ 三者均可供藥；血栓須加強提醒、子宮外孕病史強調追蹤、PID 加強雙重避孕衛教
2 疑似懷孕／不願驗孕	● 不供藥	✓ 不願驗孕改 ● 供藥+告知+追蹤；已確診懷孕維持不給藥
3 異常陰道出血	● （建議改 ●）	✓ 維持 ● 不供藥、轉介（醫學會不採改 ● 之建議）
4 體重／BMI	● 待確認	✓ 問卷選填收集，未填不得拒絕供藥
5 嘔吐補服	● 待確認	✓ 設快速通道（24 小時

內、自費) + 併同提供轉介
婦產科之選擇

流程分兩階段：階段一・線上評估（民眾自行上網填寫，於填問卷過程即完成篩選——命中禁忌或須就醫者線上導引就醫、不產生條碼、不必到藥局白跑）
→ 階段二・到局現場（本人持 QR Code 到試辦藥局，身分核對後現場評估、供藥）。

三種處置結果：● 不供藥、直接轉介（婦產科／醫療院所）● 先供藥＋衛教＋轉介或通報（以預防懷孕為第一優先）● 可供藥（完成衛教後交付）

✓ 「醫學會已定案」＝經 2026-08-03 婦產科醫學會回應確認之項目。● 「提醒 5 場」＝仍待後續場次確認之項目。🔗 各項處理建議之理由不在本表贅述；詳《第 4 場_流程表待拍板清單》對應議題。

○、制度定位（2026-08-03 醫學會提醒，新增）

藥局供藥係「來不及就醫或無法就醫者之替代方案」，非優先途徑。最佳做法仍為由婦產科醫師評估——若民眾來得及就醫，應鼓勵其就醫評估。流程設計與衛教文字不宜使民眾形成「先到藥局、不得已才看婦產科」之順序認知。本節文字應併入衛教單張與線上評估表首頁說明。〔醫學會 2026-08-03〕

一、流程總覽

📄 完整流程圖請見審議平台「藥局判斷流程圖」頁面：

<https://yilingwork.github.io/ecp-trial-scheme/flowchart.html>（瀏覽器開啟即可檢視、可列印）——含檢核步驟＋結果框、階段一線上／階段二藥局分區、醫療與社政轉介分開、✓ 醫學會已定案之標註。

本檔以下各節（二～九）為流程圖各步驟之詳細判斷準則、衛教清單與依據；流程圖與本檔為同一套內容之兩種呈現，以 HTML 圖為單一視覺來源。

階段一・線上評估（民眾自行上網填寫，尚未到藥局）

於填問卷過程逐步篩選；命中任一●者，系統線上告知就醫、不產生購藥條碼。

順序：禁忌 → 懷孕 → 出血 → 時效。

二、① 禁忌檢核（仿單禁忌，任一「是」即●不給藥）

詢問／ 判斷方		
# 檢核項目	式	處置
1 對 LNG 成分過敏	詢問過敏史	●轉介（本試辦僅 LNG、無替代品項）
2 嚴重肝功能障礙	依國內仿單禁忌詢問病史	●轉介（禁忌症）。「嚴重肝功能障礙」指肝硬化、肝衰竭、黃疸、腹水；B 肝帶原、輕度肝功能異常、脂肪肝不屬此列、可正常給藥

非禁忌、正常給藥（勿誤擋）：血栓病史（VTE）、子宮外孕病史、骨盆腔發炎（PID）均非 LNG 禁忌，正常供藥；子宮外孕僅「疑似急性現症」才轉介。✅
〔議題 1・醫學會已定案〕

2-1 議題 1 三項病史之處置細則（2026-08-03 醫學會定案）

病史	供藥與否	應加強之衛教／提醒
血栓病史（VTE）	✅可供藥	用藥要比較小心、須特別提醒民眾。雖實際發生血栓者極少（「十萬個人才十多個」），但發生過的人若沒好好控制，再發率高很多倍

子宮外孕病史

✅ 可供藥

（雖不見得與使用黃體素有
關）。〔醫學會〕

曾發生者再次子宮外孕比例
較高 → 務必提醒本人一定
要回診追蹤；不追蹤者風險
顯著較高。強化子宮外孕警
訊衛教（單側下腹劇痛、異
常出血即就醫）。〔醫學
會〕

骨盆腔發炎（PID）病史

✅ 可供藥

此類個案常因反覆無防護性
行為而反覆感染（PID 亦屬
性傳染病之一）→ 加強
「保險套＋常規避孕藥」雙
重避孕衛教與性病防治衛
教。〔醫學會〕

⚠️ 唯一例外——疑似急性子宮外孕現症（單側下腹劇痛＋面色蒼白＋冒冷汗）

→ 🚑 逕送有婦產科之急診。此非用藥禁忌，而係病人本身為救命外科急症。

📎 仿單查證附註（血栓）：國內 LNG 仿單對血栓之記載因含量規格而異。已查
核 13 張現行有效許可證仿單：2 張 0.75 毫克品項（046441「培力」愉婷錠、
027418 韻急停錠）均載有血栓警語，列於【特殊警告及使用上注意事項】、非
禁忌症，處置為「需小心觀察，評估利弊比率後使用」；11 張 1.5 毫克品項均無
血栓警語，且藥效學段落明載「在使用劑量下，Levonorgestrel 不會顯著改變凝
血因子」。引用仿單時應指明品項，不宜泛稱「國內仿單有提醒」。詳《查證_
國內 LNG 仿單血栓注意事項》。

三、② 懷孕可能性評估（依日本核對表，含「3 週驗孕」判準）

 本步驟還原第 3 場所參照之日本核對表並補「3 週驗孕」判準（僅「有懷孕徵兆 + 3 週前曾無防護性行為」之窄族群才需驗孕，其餘不需驗孕即可給藥）。設計理由詳議題 2。

步驟	詢問／判斷方式	處置
① 徵兆	是否有懷孕徵兆（週期不規則／末次月經已逾週期／末次月經不確定〔經量少、週期短〕／產後流產後月經未恢復）？	無徵兆 → 續問 ③ （不需驗孕）；有徵兆 → 續下
② 3 週驗孕	有徵兆者再問：距今「3 週以前」是否曾有無防護性行為？	否（僅近 3 週內發生）→ 不需驗孕、可給藥（服用前追加「不排除本次之前懷孕之可能」說明）；是 → 續下（驗孕）
③ 驗孕結果	3 週前曾有性行為者 → 建議使用驗孕棒	陽性（已確診懷孕）→  不給藥、轉介婦產科（本藥懷孕用藥分級屬 X 級，已確定懷孕不應使用；並確認懷孕位置、排除子宮外孕、產檢）陰性 → 續問 ③ 不願驗孕 →  供藥（不因不願驗孕而擋藥） + 下列告知與追蹤

3-1 不願驗孕者之處置（2026-08-03 醫學會定案，由 改 ）

不必因「不願驗孕」或「疑似懷孕」即擋藥，改以充分告知處理。〔醫學會〕

供藥時應完成之告知（納入個人化衛教清單）：

1. 若已確定懷孕，即不應服用本藥；本藥對已成立之懷孕無效，亦無法終止懷孕。
2. 若疑似懷孕，務必注意後續追蹤——可能於本次之前即已受孕而不自知（例如 5 天前曾有不安全性行為、未全程使用保險套），本次又有未保護之性行為而來服藥，惟其實已無效。
3. 月經未按預期時間到來，或出現亂經，應即找醫師。
4. 服藥後約 3 週建議驗孕或回診確認避孕成功。

△ 追蹤要求（醫學會特別提出）：本試辦及未來正式制度均無強制民眾就醫之權力，經建議轉介者仍可能不就醫。故必須記錄並追蹤「經建議轉介卻未就醫者」之後續情況，累積資料供未來政策參考。此追蹤機制與第 5 場（第 12、13 章）追蹤設計連動。

四、③ 異常陰道出血評估（兩周法）

步驟	詢問／判斷方式	處置
周①	最後一次月經什麼時候？	續下
周②	該次出血與平常月經有無不同（量、天數、顏色）？	續下
判定	不同、說不清楚、或當下正在出血且無法判斷是否為月經	 維持不供藥、轉介婦產科查出血原因（排除子宮外孕、子宮內膜病變等，出血鑑別屬醫師專業）；合併疑似子宮外孕急性徵象（單側劇痛、面色蒼白冒冷汗）→ 視為急診
判定	月經正常、無異常出血	續周 ④

✓ [議題3・醫學會已定案] 維持●不供藥、直接轉介。醫學會明確表示不採「改●先給藥＋當日轉介查因」之建議，理由為異常出血當中有部分情形服藥後會出問題。📎附記：本項與國際指引（FSRH／ACOG「照常供藥＋轉介排除外孕」）方向不同，係採較嚴格之把關，理由已記錄於會議紀錄。

五、④ 時效窗口（距最近一次未受保護性行為之時數）

時數	判定	處置
72 小時內	LNG 有效	通過線上篩選（時效題於到場當下再重算）
72-96 小時	LNG off-label、無可靠療效數據	●維持轉介、不給藥（已定案・非議題）；72h 後效果未知（國內仿單：24h 95%／48h 85%／72h 58%／>72h 未知），逾時線上即導引就醫、不產生條碼
超過 96 小時	LNG 已無效	●／轉介婦產科評估 UPA（120 小時內）／含銅子宮內避孕器（5 日內），口頭告知剩餘時數之急迫性

此為「效果」而非「安全」判斷準則。線上初篩逾 96h 即導引就醫、不產生條碼；72h 內者時效題仍須於到場當下重算（防填答與到場之時間差）。通過 ①－④
→ 系統產生 QR Code（購藥條碼）＋顯示附近可購藥之試辦藥局。

階段二・到局現場（本人持 QR Code 至試辦藥局）

六、⑤ 前置確認（到局身分核對）

#	檢核項目	詢問／判斷方式	處置
1	本人親領	掃碼調閱線上填答；核對到場者＝線上填答者＝證件本人（不可代購）	不符 →  不供藥
2	個資同意	確認線上已簽署個人資料提供同意書	不符 →  不供藥
3	時效重算	時效題以到場當下重算（時數、當下是否出血）；如已逾時或新增出血 → 回 ④／③ 對應處置	逾時／新增異常 → 依對應步驟

 不供藥：不符本人親領要件（代購／身分不符）者，本試辦不予供應；得依現行程序至醫療院所就醫取得。（核對相符、仍在時效內 → 續問 ⑥）

七、⑥ 需醫療／社政銜接檢核（ 先供藥＋衛教＋轉介／通報，以預防懷孕為第一優先）

#	檢核項目	處置
1	疑似性暴力／性侵害	先供藥；藥師為責任通報人員，依法 113 通報（單一窗口），由社工介入並陪同至具社工之醫院（一站式服務）就醫採證；避免個案重複陳述
2	性傳染病風險（伴侶已知感染、新／陌生伴侶且無套、本人有症狀、多重性伴侶）	供藥＋建議至婦產科接受性病篩檢
3	短期重複使用（如一個月內再次購買）	供藥（重複使用無嚴重安全疑慮，惟月經易紊亂）＋主動提供常規避孕衛教＋轉介

#	檢核項目	處置
4	哺乳中	婦產科 + 納入追蹤 供藥 + 衛教。已查證國內 LNG 仿單無「暫停 24h」→ 依國際「可繼續哺乳」 （衛教：服藥前先哺乳、避免服後馬上哺乳；非議題）。衛教內容已納入基礎衛教單，不另發個別衛教單
5	服用肝酵素誘導劑（部分抗癲癇藥、聖約翰草等）	供藥 + 告知效果可能降低 + 詳細諮詢用藥／保健食品 （台灣得在同意 + 持健保卡下查雲端藥歷核對）。依國內仿單「效果可能降低、告知醫師／藥師」、不另設劑量調整；非議題。衛教內容已納入基礎衛教單，不另發個別衛教單
6	非通報之社會風險個案（脆弱家庭等）	供藥 + 於衛教單提供社福資源 QR Code，鼓勵自主聯繫 （不強制轉介、不追蹤）
7	體重過重（>70kg／BMI>26） 	供藥（本試辦僅 LNG） + 告知高 BMI 可能降低效果。體重資料於線上問卷「選填」收集，詳 7-1 〔議題 4・醫學會已定案〕
8	血栓／子宮外孕病史／PID 	供藥 + 依 2-1 表加強對應提醒與追蹤衛教〔議題 1・醫學會已定案〕
9	不願驗孕（階段一帶入） 	供藥 + 依 3-1 完成四項告知 + 納入未就醫追蹤〔議題

皆「否」→●給藥＋一般衛教。

7-1 體重資料收集方式（2026-08-03 醫學會定案）

1. 可以收集，但列為「選填」（option）——體重過重會使效果較差，資料可收集並供後續追蹤分析。
2. 不得因未填而拒絕供藥——醫學會明確表示「沒有說不填就不能給藥，沒有到這樣」。
3. 理由：部分女性對體重敏感、不願填寫；若因未填而拿不到藥並不妥當，婦女團體亦不易接受強制填寫。
4. 有填答且 $>70\text{kg}$ / $\text{BMI}>26$ 者 → 於個人化衛教清單加掛就醫轉介指引衛教單，並口頭告知「效果可能降低」。

八、●可供藥：標準衛教項目（系統依填答自動帶出個人化清單，藥師逐項確認）

1. 盡速服用（越早效果越好）；不強制當場服用（願意者可當場服）。
2. 服藥後短時間內（2-3 小時）嘔吐須補服。✓[議題5・醫學會已定案]嘔吐補服快速通道詳 8-1。
3. 常見副作用：月經提前／延後、點狀出血、噁心、頭痛。
4. 警訊衛教：月經延遲逾 1 週應驗孕；服藥後約 3 週建議驗孕或回診確認避孕成功；出現下腹劇痛或異常出血應立即就醫（子宮外孕警訊，發生率約萬分之一，惟延誤危險）。
5. ECP 為補救措施、非常規避孕；提供常規避孕與雙重避孕衛教及銜接方式。依醫學會提醒，明確告知「真正妥適的避孕方式是保險套＋常規避孕藥之雙重避孕」。
6. 哺乳中之服藥資訊：可繼續哺乳（已查證國內仿單無「暫停 24h」→依國際指引）；建議服藥前先哺乳、避免服後馬上哺乳。
7. 併用肝酵素誘導劑（部分抗癲癇藥、聖約翰草等）之交互作用資訊：效果可能降低；用藥中應告知醫師／藥師。

8. 衛教單附社福資源與相關諮詢 QR Code。
9. 依○、制度定位，告知「來得及就醫者仍建議由婦產科醫師評估」。
10. 藥師於系統逐項確認衛教完成 → 完成給藥紀錄、結案（防跨店重複購買）。

8-1 嘔吐補服快速通道（2026-08-03 醫學會定案）

醫學會原則不反對設置，惟須符合下列條件：

項目	規則
時間限定	24 小時內憑原條碼／原給藥紀錄回店
費用	須再收取一次費用（本項本即自費項目）
系統處理	藥師確認情節後以「補服代碼」記錄、免重新評估、不計入短期重複使用、跨店適用
併同提供轉介婦產科之選擇	嘔吐補服或建議轉介婦產科，提供補服之外的另一種選擇；補服流程須同時提供另一條就醫管道

轉介理由（醫學會說明）：

1. 若嘔吐係藥物本身引起，再服一劑很可能再次嘔吐、甚至更嚴重（連續兩次劑量累積更高）。
2. 若嘔吐係其他原因引起，待狀況改善後再服或許無虞——惟須由醫師判斷。
3. 婦產科端可一併處理嘔吐問題，並告知其他可行的避孕方式（不必然只能服用緊急避孕藥）。

各情境對應之個人化衛教清單（系統依填答自動帶出）

「基礎清單」＝上列 1-9 項（哺乳中與服用肝酵素誘導劑之資訊已納入基礎衛教單第 6、7 項，不另設個別衛教單）。實體衛教單共三種：①基礎衛教單（全員）、②社福資源衛教單（㉖-1 與 ㉖-6 共用同一份）、③就醫轉介指引衛教單（㉖-7～㉖-9、嘔吐補服等六情境共用同一份）；另 ㉖-2、㉖-3 之加值衛教維持個

別內容。系統依線上填答與現場評估結果，於基礎清單上自動加掛對應衛教單與提醒（連動資訊系統功能 B-6「個人化衛教清單」）。

情境（處置結果）	衛教清單內容
 一般供藥	基礎清單 1-9（全員必做；已含哺乳、肝酵素誘導劑資訊）
 疑似性暴力／性侵害（⑥-1）	基礎清單 + 社福資源衛教單（113 通報與一站式服務流程說明〔就醫會經歷什麼、社工陪同〕、保留證據提醒、心理支持資源；與 ⑥-6 共用同一份）
 性傳染病風險（⑥-2）	基礎清單 + 性病篩檢衛教（建議婦產科篩檢項目、windows period 概念） + 保險套正確使用
 短期重複使用（⑥-3）	基礎清單 + 強化常規避孕衛教（LARC 等選項比較、轉介婦產科避孕諮詢） + 月經紊亂預期說明 + 追蹤說明
 哺乳中（⑥-4）	基礎清單即可（哺乳資訊已納入基礎衛教單第 6 項，不另加掛）
 服用肝酵素誘導劑（⑥-5）	基礎清單即可（交互作用資訊已納入基礎衛教單第 7 項，不另加掛）
 非通報之社會風險個案（⑥-6）	基礎清單 + 社福資源衛教單（與 ⑥-1 共用同一份；藥師引導：QR Code 內容逐項說明、鼓勵自主聯繫）
 體重過重（⑥-7，僅有填答者）	基礎清單 + 就醫轉介指引衛教單（口頭併告知：效果可能降低）
 血栓病史（⑥-8） 	基礎清單 + 就醫轉介指引衛教單（口頭併提醒：醫學會囑用藥須較小心、應特別提醒）
 子宮外孕病史（⑥-8） 	基礎清單 + 就醫轉介指引衛教單（口頭併

情境（處置結果）	衛教清單內容
	強化：子宮外孕警訊、「務必回診追蹤」之明確叮嚀）
● PID 病史（⑥-8）	基礎清單 + 就醫轉介指引衛教單（口頭併強化：雙重避孕〔保險套 + 常規避孕藥〕與性病防治衛教）
● 不願驗孕（⑥-9）	基礎清單 + 就醫轉介指引衛教單（口頭併完成 3-1 之四項告知） + 納入未就醫追蹤
● 嘔吐補服（8-1）	基礎清單 + 就醫轉介指引衛教單（口頭併說明轉介婦產科之選擇：再服可能再吐、可一併處理嘔吐、可討論其他避孕方式）
● 不供藥、直接轉介	無供藥衛教；改為就醫指引（轉介事由說明、就醫時效急迫性〔UPA ≤ 120h / 含銅 IUD ≤ 5 日〕、就醫會經歷什麼） + 轉介單 + 納入未就醫追蹤
● 不符本人親領	替代途徑告知（現行就醫程序、時效急迫性） + 記錄已告知時間

九、依據與待確認事項

9-1 已定案項目（2026-08-03 醫學會回應）

議題 1-5 全數獲回應並定案，處置分別載於 2-1、3-1、四、7-1、8-1 各節。另新增：

1. 制度定位（○節）：藥局供藥為就醫不及之替代方案。
2. 未就醫者追蹤（3-1）：須記錄並追蹤經建議轉介卻未就醫者之後續情況。
3. 雙重避孕衛教（八-5）：明確告知保險套 + 常規避孕藥為妥適避孕方式。

9-2 嚴重肝功能障礙之定義（補充）

1. 婦產科臨床實務判準：肝功能指數（GOT／GPT）達正常值兩倍以上即須小心。⚠
正常值上限依各檢驗室標準略有不同，引用時應查證正式參考值。
2. 「嚴重到何種程度不得服用」須由腸胃肝膽科界定——醫學會建議此定義詢問腸胃肝膽科較為正式（非婦產科專業範圍）。待洽腸胃肝膽科專家確認。
3. 判斷時應權衡：胃肝功能風險 vs. 未避孕之風險，並考量該個案未必只能使用緊急避孕藥——婦產科端可提供其他避孕方式解決其需求。

9-3 仍待後續確認事項

- 未成年（兒少）之供藥條件與家長同意——第 4 場（第 8 章）討論後補入（未滿 16 歲之通報屬現行法，須先於流程加年齡節點）。
- 追蹤機制（第 21 天追蹤、追蹤方式）——第 5 場（第 12、13 章）討論後補入；須併同納入 3-1「經建議轉介卻未就醫者」之追蹤設計。
- 性暴力個案之法定通報管道與 113 之關係、24 小時時限、轉介操作——已規劃函詢衛福部保護司。函詢時點：俟第 4 場會議確認所有轉介情境後再一併函詢。
- 嚴重肝功能障礙之量化定義——待洽腸胃肝膽科（見 9-2）。
- △ 禁忌欄依品項而異之影響：已查核之 13 張國內 LNG 仿單中，多數（11 張）禁忌欄僅列「成分過敏」，但衛部藥輸字第 027979 號（韻急停錠 1.5 毫克）另列「嚴重肝機能不全」與「懷孕」為禁忌，027418 號亦將「已懷孕」列入禁忌欄。故「LNG 唯一絕對禁忌 = 成分過敏」之陳述須說明各廠仿單不一致，或限定於特定品項。此點影響 ❶ 禁忌檢核與議題 2 之論述基礎，建議提請專家會議確認試辦指定品項後據以定稿。詳《查證_國內 LNG 仿單血栓注意事項》。

9-4 原有依據

- 國際指引（FSRH／ACOG／WHO）原則：供應 ECP 前不需內診或驗孕、不得因體重／肥胖拒絕供應；本流程之驗孕關卡係採日本模式（僅於懷孕可能性存疑時實施），設計理由為「防誤判、即時轉介」而非安全風險。
- 各項之國際實證與改動理由，詳《第 4 場_流程表待拍板清單》議題 1－5／非議題項及附錄（國際實證依據）。